# Evaluación del dolor en el paciente oncológico

## Dolor oncológico

tech

# CONTENIDO

1. Introducción

2. Historia clínica: anamnesis

3. Escalas de evaluación del dolor

Escalas de evaluación unimodal
Evaluación de evaluación multimodal
Escalas de evaluación de dolor neuropático

4. Métodos fisiológicos

5. Bibliografía

# Introducción

La evaluación del dolor es esencial para su correcto tratamiento. Es necesario que se realice de forma continua, no solo en el momento del diagnóstico, sino también en cada una de las visitas de seguimiento en consulta. Es posible que el dolor haya experimentado cambios como consecuencia de la evolución de la enfermedad o por el inicio de nuevos tratamientos.

La evaluación del dolor debe aportar datos de intensidad, localización, características, irradiación, respuesta al tratamiento, etc.

Es importante el empleo de las escalas de dolor en su evaluación.

Con todos estos datos será elaborada una estrategia terapéutica que permita al paciente el control del dolor.

# Historia clínica: Anamnesis

Para realizar una evaluación exhaustiva del dolor, se debe comenzar con la recogida de datos en la entrevista clínica. Es posible iniciar la historia clínica recogiendo los datos personales del paciente, seguidos de los antecedentes personales. A continuación, se hace constar los hábitos tóxicos. Es importante conocer si el paciente consume o ha consumido algún tipo de drogas en relación al inicio del posible tratamiento con opioides. En tercer lugar, pueden aparecer las alergias, se debe enumerar las alergias sospechadas y confirmadas. Esto ayudará a evitar emplear los fármacos que ya han provocado una reacción local o sistémica en el paciente. Seguidamente, preguntar por la existencia de enfermedades de interés e intervenciones quirúrgicas realizadas. Por último, se debe recoger el tratamiento realizado actualmente y los que se han abandonado consecuencia de alergias o secundarismos.

En relación al dolor oncológico, se realiza una descripción lo más completa posible sobre el dolor recogiendo sus características, localización, irradiación, factores que aumentan o disminuyen el dolor, tratamientos curativos o paliativos realizados (cirugías, quimioterapia o radioterapia), tratamientos analgésicos (actuales y abandonados) y tratamientos coadyuvantes. Por último, es importante recoger datos sobre la situación psicológica y emocional actual del paciente en relación con su diagnóstico, pronóstico y control del dolor.

Para completar la historia clínica, deben constar los datos de la exploración física realizada, las pruebas complementarias realizadas y por último el juicio clínico.

La evaluación del dolor debe incluir *(figura 1)*:

- **Tipo de dolor**

Como se veía en el tema 2, es importante reconocer y diferenciar el dolor somático del dolor visceral y del neuropático para su correcto tratamiento.

- **Intensidad del dolor**

Es el parámetro más difícil de valorar. Se proponen al paciente diferentes escalas (comentadas ampliamente a lo largo del tema), mediante las que tendrá que indicar la gravedad percibida del mismo. El paciente debe valorar la intensidad del dolor basal y del dolor irruptivo.

- **Patrón del dolor**

El paciente debe definir cuándo se inicia el dolor, su evolución a lo largo del día, si es continuo, intermitente o pulsátil. La existencia o no de dolor irruptivo.

- **Síntomas que acompañan al dolor**

Puede que aparezcan síntomas como náuseas, sudoración, mareo, etc.

- **Factores que aumentan el dolor**

El dolor puede agravarse por el movimiento, la vibración, la deglución, la masticación, la ansiedad, etc.

- **Factores que disminuyen el dolor**

El dolor puede disminuir por el reposo, la administración de calor, la toma de medicación analgésica, etc.

- **Efectos del dolor sobre las actividades de la vida diaria**

La posibilidad de realizar o no las actividades de la vida diaria, como el aseo personal, las relaciones sociales y familiares, la deambulación, etc.

- **Evolución del dolor**

Debe figurar en cada una de las consultas. Es necesario preguntar al paciente por el control del dolor basal y del dolor irruptivo para poder realizar la modificación correcta del tratamiento.

Qué cambios ha experimentado si se ha realizado un tratamiento de quimioterapia, si ha aparecido toxicidad post radioterapia o tras una intervención quirúrgica.

# Escalas de evaluación del dolor

Actualmente disponemos de numerosas escalas que ayudan a la valoración del dolor. Las escalas se dividen en unidimensionales y multidimensionales.

## Escalas verbales unidimensionales

Estas escalas miden la intensidad del dolor. Son fáciles de aplicar y su fiabilidad es aceptable, pero no contemplan la naturaleza multidisciplinaria del dolor *(figura 2)*:

- Escala visual analógica
- Escala verbal simple
- Escala numérica
- Escala de expresión facial

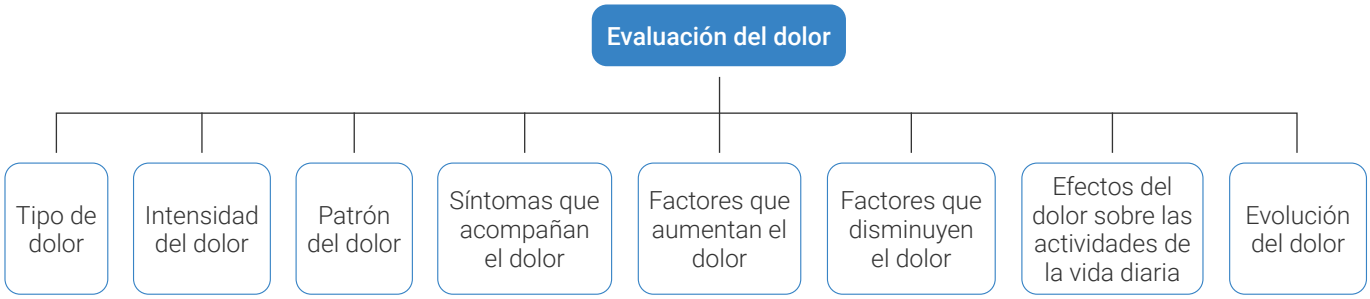



**Figura 1.** Evolución del dolor.

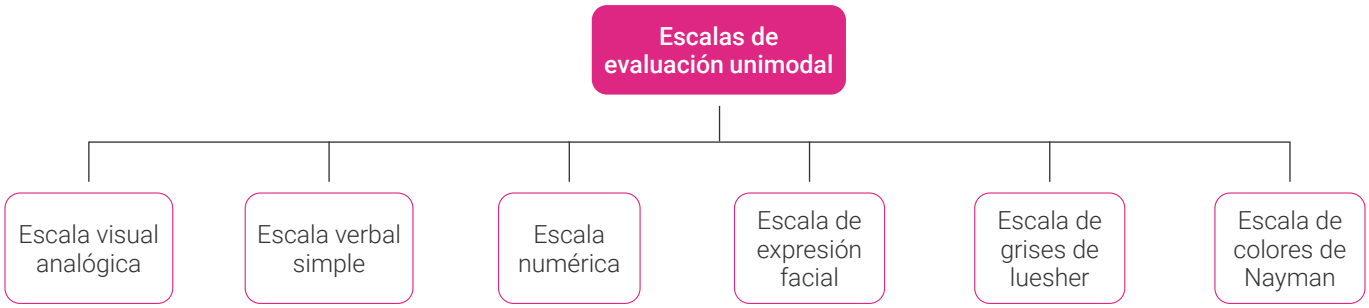



**Figura 2.** Escala de evaluación unimodal.

- Escala de grises de Luesher
- Escala de colores de Nayman

## Escala visual analógica (EVA)

Consiste en una línea continua de 10 centímetros. Esta línea representa la intensidad de dolor. En un extremo aparece la expresión "no dolor", en el otro extremo aparece la expresión "el peor dolor imaginable". La intensidad de dolor es la distancia entre el extremo de "no dolor" y el punto marcado en la línea por el paciente.

Ideada por Scott Huskinson en 1976, se trata de una escala de fácil aplicación, pues el paciente no describe con términos su dolor. Esto hace que sea la escala de dolor que se usa más frecuentemente.

Entre las ventajas se encuentra su validez, simplicidad y reproducibilidad. Su única desventaja es la imposibilidad de realizarla en pacientes con deterioro cognitivo o alguna otra situación especial.

También es posible realizar un EVA de 24 horas. Se mide la variación de intensidad del dolor a lo largo del día. Se trataría de solicitar al paciente una valoración media de su sensación dolorosa acompañado de su intensidad máxima y mínima del dolor *(figura 3)*.

## Escala verbal simple

Se trata de la valoración de dolor más básica, de aplicación muy sencilla. Descrita por Keele en 1948, el paciente debe relacionar su dolor con un término (sin dolor - dolor leve - dolor moderado - dolor intenso) *(figura 4)*.

A cada uno de estos términos se les asigna una puntuación entre 0 (sin dolor) y 4 (dolor intenso) de cara al tratamiento estadístico de los resultados y a la valoración práctica del mismo. Las palabras utilizadas son descripciones relativas y no tienen aceptación universal, son conceptos que varían de una persona a otra, así como de tiempo en tiempo, incluso para un mismo paciente. Aunque cada palabra tiene asignado un valor numérico en la escala, no se pueden asumir intervalos iguales entre los diferentes puntos.

Los números ayudan a determinar niveles relativos de dolor, pero el investigador no debe olvidar estas limitaciones a la hora de realizar análisis estadísticos. Aunque se emplea en numerosos ensayos clínicos sobre dolor, es inespecífica, no muy sensible y no siempre reproducible *(figura 4)*.

## Escala numérica

Es una de las escalas más comúnmente empleadas, introducida por Downie en 1978. Al paciente se le pide que relacione la intensidad del dolor con un valor numérico entre 0 y 10. Con este tipo de escala, el dolor se considera un concepto unidimensional simple y se mide según su intensidad. La escala es discreta, no continua, pero para realizar análisis estadísticos pueden asumirse intervalos iguales entre categorías. Es útil como instrumento de medida para valorar la respuesta a un tratamiento seleccionado.

La escala numérica puede ser empleada en el contexto de escalas multidimensionales que evalúan varios síntomas con la misma metodología. Esto resulta importante porque, como se ha dicho antes, el dolor no suele ser un síntoma aislado en estos pacientes y se pueden establecer asociaciones de síntomas que son importantes a la hora de planificar el tratamiento *(figura 5)*.

### Escala de expresión facial

Es una escala para medir el nivel de intensidad de dolor en niños. Es una escala de seis caras que se presentan horizontalmente. El niño escoge la cara que mejor representa la intensidad de su dolor. A cada cara se le asigna un valor numérico de 0 a 10 (0-2-4-6-8-10). El evaluador debe explicar al niño la relación entre las diferentes caras y la intensidad del dolor empleando los términos que se relacionan con las caras de los extremos "sin dolor" y "muchísimo dolor". La escala ha sido validada por Hicks y cols., en una muestra de niños y adolescentes de entre 5 y 12 años de edad *(figura 6)*.

### Escala de grises de Luesher

Esta escala utiliza una escala de grises como variante de la intensidad del dolor empleando diferentes tonalidades en una barra horizontal o vertical. Los tonos varían entre el blanco que representa la ausencia de dolor y el negro que representa el máximo dolor. El color señalado por el paciente se traslada a una escala numérica.

Esta escala permite tener información a la vez sobre la intensidad del dolor y sobre el estado psicológico del paciente. Al paciente se le pregunta cuál es el color que más le gusta y cuál es que menos le gusta. La interpretación de los colores es la siguiente: el blanco es indicativo de confianza y de colaboración, el negro indica pesimismo y falta de colaboración, los grises indican una disminución de la actividad, siendo el paciente más pasivo cuanto más gris es el color elegido *(figura 7)*.

### Escala luminosa analógica de Nayman

Esta escala emplea una gradación de la intensidad de la luz para la valoración del dolor. El paciente debe establecer una relación entre la intensidad de su dolor y una gradación de intensidad de la luz. La escala son colores en una gradación de intensidad de luz que van desde la ausencia de dolor (blanco) al dolor máximo (violeta) *(figura 8)*.

## Escalas multidimensionales

Estas escalas evalúan distintos componentes del dolor. Incluyen términos psicométricos. Son especialmente útiles en el caso de pacientes con dolor crónico *(figura 9)*.

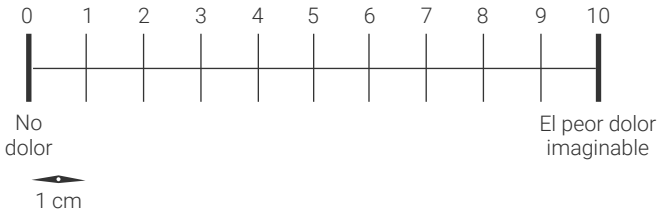



**Figura 3.** Escala visual analógica.

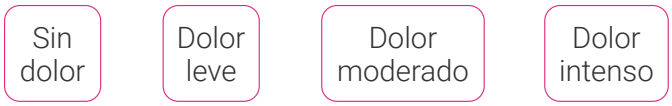



**Figura 4.** Escala verbal simple.

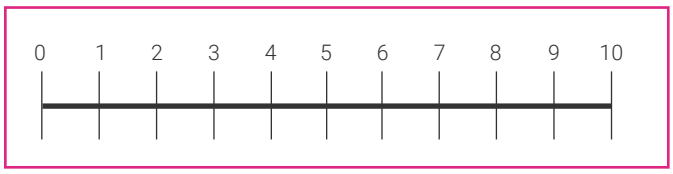



**Figura 5.** Escala numérica.

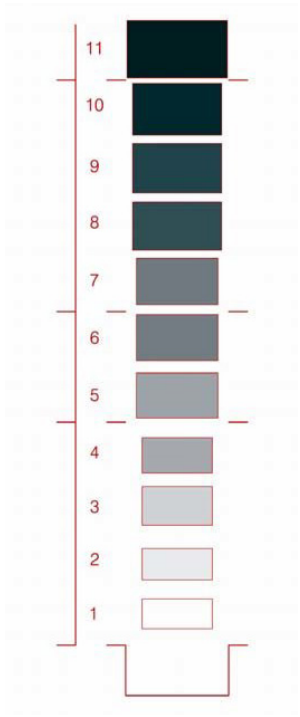



**Figura 7.** Escala de grises de Luesher.

**Figura 6.** Escala de expresión facial.

### *McGill Pain Questionnaire*

En esta escala se miden dimensión sensorial, afectiva y cognitiva. Creada por Melzack en 1975 con el objetivo de proporcionar una valoración del dolor desde la perspectiva sensorial, afectivo-motivacional y evaluativa. En concreto, el instrumento consta de 78 adjetivos distribuidos en 20 grupos, incluyendo cada grupo de 2 a 6 adjetivos que califican la experiencia dolorosa. Cada uno de los términos descriptivos tiene asignado un número o rango que permite obtener una puntuación de acuerdo a las palabras escogidas, con lo que se obtiene el denominado *Pain Rating Index* (PRI) o Índice de Valoración del Dolor.

Ha sido validado al español mostrando su reproducibilidad para la evaluación del dolor crónico. Este cuestionario es útil para evaluar los aspectos cualitativos y relacionados con el estado emocional; no obstante, los sistemas de puntuación resultan complicados, lo que genera dudas sobre la fiabilidad de las puntuaciones obtenidas.

Como inconvenientes se enumeran el tiempo necesario para realizarla, que no existe una categoría para el "no dolor" y que presenta un vocabulario difícil de entender, ya que los adjetivos pueden ser interpretados de diferentes formas dependiendo de la edad, sexo, nivel cultural o posición social *(figura 10)*.

### Cuestionario *Brief Pain Inventory short form* (BPI)

Se trata de un cuestionario multidimensional que utiliza una escala numérica para cuantificar del 1 al 10 los ítems del cuestionario. Consta de 7 escalas numéricas verbales que evalúan tanto la intensidad del dolor como distintos elementos relacionados con la actividad general, sueño, trabajo, estado de ánimo, capacidad de andar, relaciones sociales y disfrutar de la vida. En la práctica clínica diaria, puede ser tediosa su realización, por lo que se recomienda centrarse en el impacto del dolor en el estado de ánimo, en la capacidad funcional y en el descanso nocturno.

Desarrollado originalmente para el dolor oncológico, es muy utilizado en clínica e investigación para evaluar la intensidad e impacto del dolor y los efectos del tratamiento analgésico. Hay dos versiones, la larga y la corta, ambas validadas en español *(figura 11)*.

## Escalas de evaluación de dolor neuropático

Ayudan a determinar si un paciente tiene dolor neuropático o no. Las escalas validadas para dolor neuropático en general son *(figura 12)*:

### *The LANSS Pain Scale*

Se trata de una escala para la valoración del dolor neuropático. Incluye una primera parte en la que el paciente describe su dolor y una segunda parte en la que el profesional realiza una exploración. Se considera dolor neuropático si la puntuación supera los 12 puntos.

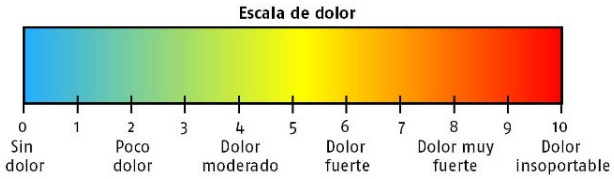



**Figura 8.** Escala luminosa analógica de Nayman.

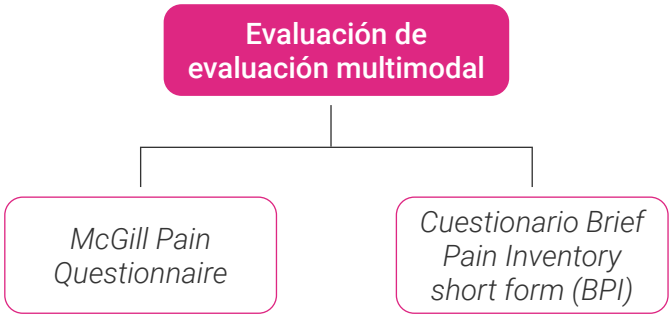
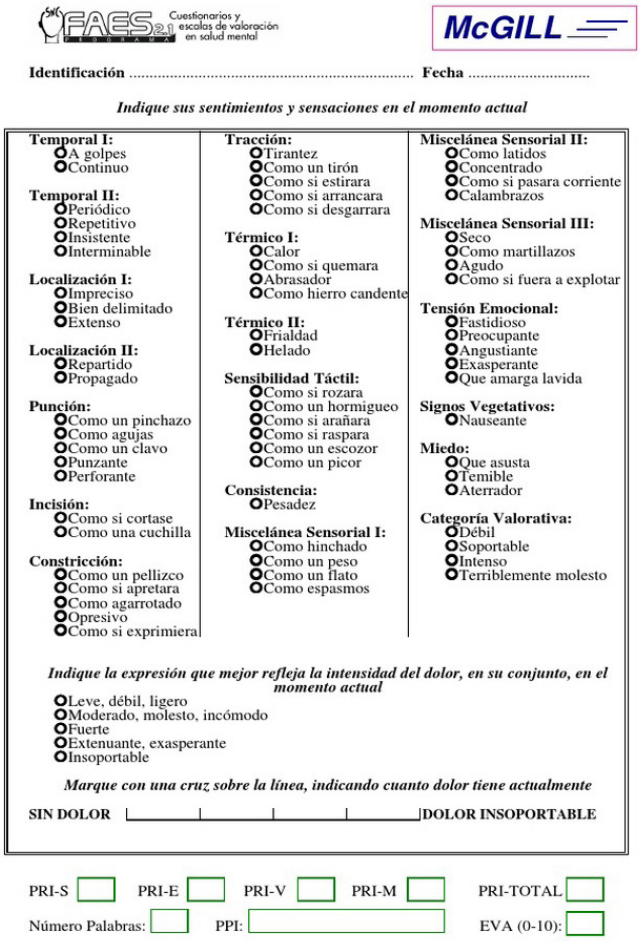



**Figura 9.** Escalas multidimensionales.



FAES Cuestionarios y escalas de valoración en salud mental

McGILL

Identificación ..... Fecha .....

*Indique sus sentimientos y sensaciones en el momento actual*

**Temporal I:**
- A golpes
- Continuo

**Temporal II:**
- Periódico
- Repetitivo
- Insistente
- Interminable

**Localización I:**
- Impreciso
- Bien delimitado
- Extenso

**Localización II:**
- Repartido
- Propagado

**Punción:**
- Como un pinchazo
- Como agujas
- Como un clavo
- Punzante
- Perforante

**Incisión:**
- Como si cortase
- Como una cuchilla

**Constricción:**
- Como un pellizco
- Como si apretara
- Como agarrotado
- Opresivo
- Como si exprimiera

**Tracción:**
- Tirantez
- Como un tirón
- Como si estirara
- Como si arrancara
- Como si desgarrara

**Térmico I:**
- Calor
- Como si quemara
- Abrasador
- Como hierro candente

**Térmico II:**
- Frialdad
- Helado

**Sensibilidad Táctil:**
- Como si rozara
- Como un hormigueo
- Como si arañara
- Como si raspara
- Como un escozor
- Como un picor

**Consistencia:**
- Pesadez

**Miscelánea Sensorial I:**
- Como hinchado
- Como un peso
- Como un flato
- Como espasmos

**Miscelánea Sensorial II:**
- Como latidos
- Concentrado
- Como si pasara corriente
- Calambrazos

**Miscelánea Sensorial III:**
- Seco
- Como martillazos
- Agudo
- Como si fuera a explotar

**Tensión Emocional:**
- Fastidioso
- Preocupante
- Angustiante
- Exasperante
- Que amarga lavida

**Signos Vegetativos:**
- Nauseante

**Miedo:**
- Que asusta
- Temible
- Aterrador

**Categoría Valorativa:**
- Débil
- Soportable
- Intenso
- Terriblemente molesto

*Indique la expresión que mejor refleja la intensidad del dolor, en su conjunto, en el momento actual*

- Leve, débil, ligero
- Moderado, molesto, incómodo
- Fuerte
- Extenuante, exasperante
- Insoportable

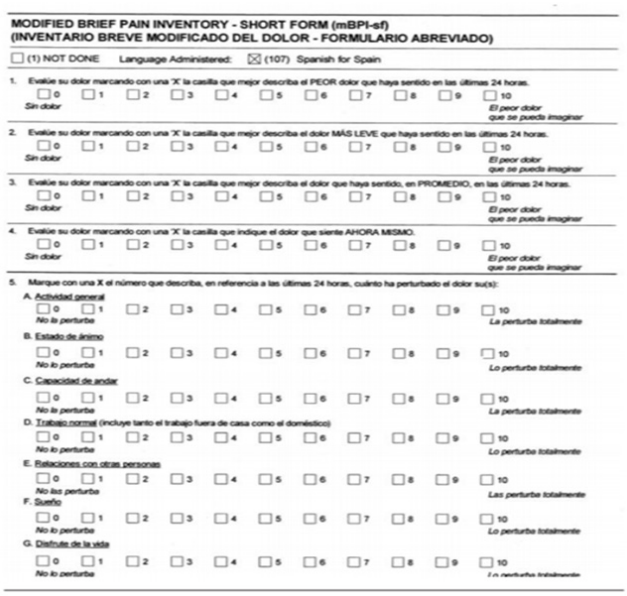
*Marque con una cruz sobre la línea, indicando cuanto dolor tiene actualmente*

SIN DOLOR |_____|_____|_____|_____| DOLOR INSOPORTABLE

PRI-S ☐ PRI-E ☐ PRI-V ☐ PRI-M ☐ PRI-TOTAL ☐

Número Palabras: ☐ PPI: ☐ EVA (0-10): ☐

**Figura 10.** Cuestionario de dolor McGill.



MODIFIED BRIEF PAIN INVENTORY - SHORT FORM (mBPI-sf)
(INVENTARIO BREVE MODIFICADO DEL DOLOR - FORMULARIO ABREVIADO)

☐ (1) NOT DONE Language Administered: ☒ (107) Spanish for Spain

1. Evalúe su dolor marcando con una 'X' la casilla que mejor describa el PEOR dolor que haya sentido en las últimas 24 horas.
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10
Sin dolor — El peor dolor que se pueda imaginar

2. Evalúe su dolor marcando con una 'X' la casilla que mejor describa el dolor MÁS LEVE que haya sentido en las últimas 24 horas.
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10
Sin dolor — El peor dolor que se pueda imaginar

3. Evalúe su dolor marcando con una 'X' la casilla que mejor describa el dolor que haya sentido, en PROMEDIO, en las últimas 24 horas.
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10
Sin dolor — El peor dolor que se pueda imaginar

4. Evalúe su dolor marcando con una 'X' la casilla que indique el dolor que siente AHORA MISMO.
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10
Sin dolor — El peor dolor que se pueda imaginar

5. Marque con una X el número que describa, en referencia a las últimas 24 horas, cuánto ha perturbado el dolor su(s):

A. Actividad general
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10
No lo perturba — La perturba totalmente

B. Estado de ánimo
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10
No lo perturba — Lo perturba totalmente

C. Capacidad de andar
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10
No lo perturba — La perturba totalmente

D. Trabajo normal (incluye tanto el trabajo fuera de casa como el doméstico)
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10
No lo perturba — Lo perturba totalmente

E. Relaciones con otras personas
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10
No las perturba — Las perturba totalmente

F. Sueño
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10
No lo perturba — Lo perturba totalmente

G. Disfrute de la vida
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10
No lo perturba — Lo perturba totalmente

**Figura 11.** Cuestionario *Brief Pain Inventory short form.*

Tiene una sensibilidad y una especificidad que va desde el 82 % al 91 % y desde el 80 % al 94 % respectivamente, comparado con el diagnóstico clínico.

Está validada en español.

### *The Neuropathic Pain Questionnaire* (NPQ)

Consiste en 12 ítems que incluyen 10 referidos a sensaciones o respuestas sensoriales y dos referidos al afecto. La forma corta del NPQ mantiene propiedades discriminativas similares con solo tres ítems. Según los estudios, tiene poder discriminativo entre dolor neuropático y no neuropático.

### *Douleur neuropathique en 4 questions* (DN4)

Consiste en siete preguntas referidas a síntomas y tres referidas a la exploración. Es fácil de puntuar y una puntuación total de 4/10 o mayor, sugiere dolor neuropático. Los siete descriptores sensoriales pueden utilizarse en un *autotest* con similares resultados. Su principal diferencia consiste en que incorpora un síntoma negativo, como es la hipoestesia. Su sensibilidad y especificidad se sitúa alrededor del 80 % al 90 %.

Originariamente escrito en francés, se ha validado en 15 idiomas, entre ellos el español.

### *PainDETECT*

Se trata de un cuestionario autorrellenable con nueve ítems que no requiere examen clínico por parte del médico. La puntuación obtenida se relaciona con la presencia o no de dolor neuropático. Si la puntuación obtenida es menor a 12, se trata de dolor de características nociceptivas.

Las puntuaciones entre 12 y 19 pueden relacionarse con dolor neuropático. Si la puntuación obtenida por el paciente supera los 19 puntos, se trata de dolor de características neuropáticas. Se ha trasladado a 22 idiomas, validado también en español.

## Métodos fisiológicos

Son pocos los métodos empleados en la práctica clínica diaria. Se citará el estudio de las respuestas psicofisiológicas del sistema nervioso autónomo, el estudio de patrones electromiográficos, los potenciales evocados, la neurografía percutánea, la determinación de péptidos opioides endógenos en LCR, los reflejos nociceptivos de dolor, la determinación de catecolaminas, cortisol y ADH, y por último la determinación de parámetros respiratorios *(figura 13).*

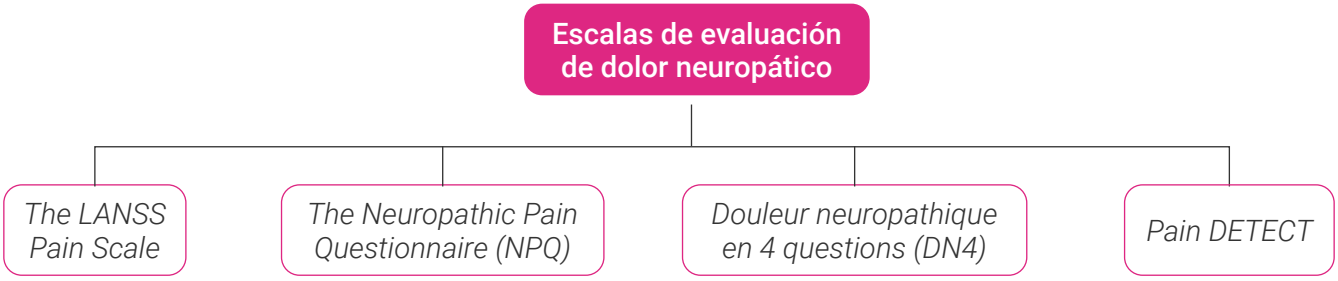



**Figura 12.** Escalas de evaluación de dolor neuropático.

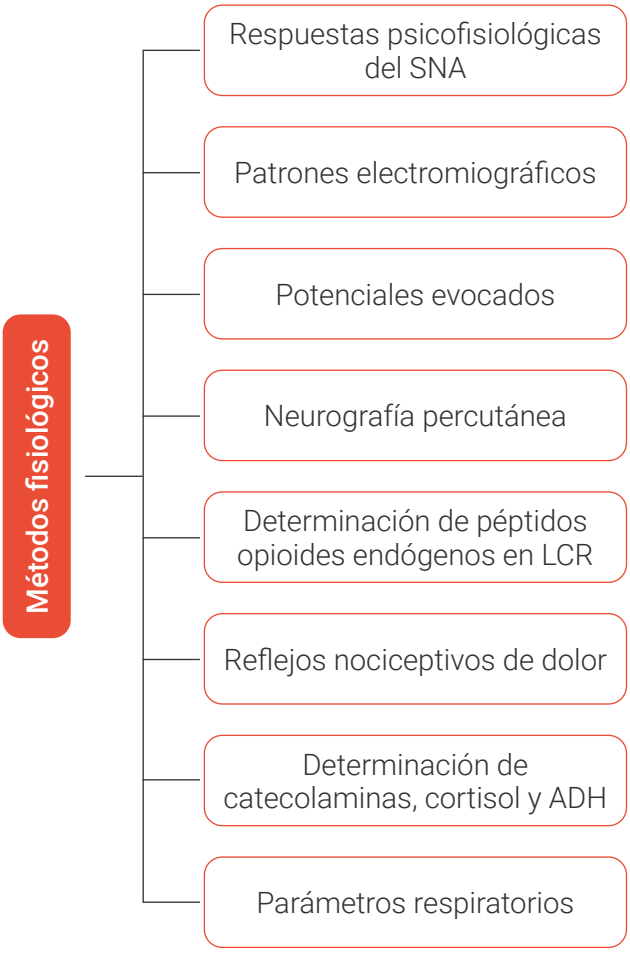



**Figura 13.** Métodos fisiológicos.

## Bibliografía

1. Vicente-Herrero, M. T., Delgado-Bueno, S., Bandrés-Moyá, F., & Capdevilla-García, L. Valoración del dolor. Revisión comparativa de escalas y cuestionarios. Revista de la Sociedad Española del dolor; 2018. 25(4), 228-236.
2. Clarett, M. Escalas de evaluación de dolor y protocolo de analgesia en terapia intensiva. Clínica y Maternidad Suizo Argentina Instituto Argentino Diagnóstico y Tratamiento; 2012.
3. García Romero, J., Jiménez Romero, M., Fernández Abascal, R., & Fernández-Abascal Puente, A. col. La medición del dolor: una puesta al día. Med Integral; 2002. 39, 317-320.
4. Jaén, J. Valoración del dolor (I).
5. REVISI, Ó. Valoración del dolor (II).
6. Melzack, R. (1975). *The McGill Pain Questionnaire: major properties and scoring methods. Pain*; 1975. 1(3), 277-299.
7. Ibáñez, R. M., & Briega, A. M. Escalas de valoración del dolor. Jano; 2005. 25, 41-44.
8. Rodríguez-Mansilla, J., Jiménez-Palomares, M., & González-López-Arza, M. V. Escalas de valoración del dolor en pacientes con demencia. Instrumentos de ayuda para el fisioterapeuta, el médico, el enfermero y el terapeuta ocupacional. Revista Española de Geriatría y GerontologíaM; 2014. 49(1), 35-41.
9. Serrano-Atero MS, Caballero J, Cañas A, García-Saura PL, Serrano Álvarez C. & Prieto J. Pain assessment (II). Rev. Soc. Esp. Dolor http://revista.sedolor.es/pdf/2002_02_06.pdf; 2002. 9:109-121.